Estilo UERJ

Simulado 8 Caderno

Prova inédita no formato da UERJ: quatro alternativas, casos longos e a armadilha da banca em cada questão.

50 questões

17 de outubro de 2026

ANTES DE COMEÇAR

Instruções

- São 50 questões de Clínica Médica, com quatro alternativas cada (A a D) e uma única correta.
- Tempo sugerido: 2 horas e 30 minutos, sem consulta, de uma vez só.
- Marque as respostas na folha de respostas da última página, e só depois abra a resolução.
- Nas questões de identificar, faça o teste do resto: liste os achados e veja se a hipótese explica todos. Antes de pedir exame ou tratamento, pergunte qual é o degrau mais simples que resolve e o que o paciente já usa.
- Na correção, anote em qual arma da banca você caiu. É isso que vai para o diagnóstico, não o total.

1 Homem de 44 anos, natural do interior de Minas Gerais, onde nadava em lagoas na infância, bebe cerca de 4 latas de cerveja aos sábados há 20 anos. Internado por hematêmese volumosa, recebeu ligadura de varizes esofágicas de grosso calibre. Exame após a estabilização: corado, anictérico, sem aranhas vasculares, sem eritema palmar, sem ginecomastia, sem ascite, baço palpável a 8 cm do rebordo costal. Exames: albumina 4,1 g/dL, INR 1,0, bilirrubina total 0,7 mg/dL, AST 32 U/L, ALT 28 U/L, GGT 48 U/L, plaquetas 64.000/mm³, HBsAg e anti-HCV não reagentes. Ultrassonografia com Doppler: fígado de superfície regular, com espessamento fibroso hiperecogênico ao redor dos ramos portais, veia porta pérvia de 15 mm, veias hepáticas pérvias, baço de 19 cm. A etiologia mais provável da hipertensão portal é:

A) Trombose da veia porta

B) Cirrose alcoólica

C) Síndrome de Budd-Chiari

D) Esquistossomose hepatoesplênica

---

2 Mulher de 63 anos, com tireoidite de Hashimoto eutireoidea em levotiroxina, apresenta em 10 semanas declínio cognitivo rápido: esquecimento, desorientação e depois dificuldade para andar e falar. Exame: MEEM 12, ataxia de marcha, mioclonias espontâneas e desencadeadas por susto; afebril. Anti-TPO 860 UI/mL (VR menor que 35), TSH 2,1 mUI/L, sódio 138 mEq/L. Líquor: 2 células/mm³, proteína 44 mg/dL, glicose normal. EEG: complexos periódicos de ondas agudas a cerca de 1 por segundo. RM: restrição à difusão no córtex frontal e parietal bilateral e nos núcleos caudados e putâmens, sem realce. Recebeu metilprednisolona 1 g/dia por 5 dias, sem nenhuma melhora. O diagnóstico mais provável é:

A) Encefalite anti-LGI1

B) Encefalopatia responsiva a corticoide associada a tireoidite

C) Doença de Creutzfeldt-Jakob esporádica

D) Demência com corpos de Lewy

---

3 Homem de 61 anos, com diabetes tipo 2 (HbA1c 8,9%) e neuropatia periférica, tem úlcera plantar indolor sob a cabeça do 1º metatarso direito há 10 semanas. Exame: T 36,7 °C, úlcera de 2 cm com fundo granuloso, sem secreção purulenta, sem eritema perilesional, sem crepitação; o estilete toca osso. Pulsos pediosos palpáveis, índice tornozelo-braquial 1,0. VHS 78 mm/h, PCR 2,1 mg/dL. Radiografia: erosão cortical na cabeça do 1º metatarso. RM: edema medular com realce na cabeça do 1º metatarso, sem abscesso. Não recebeu antibiótico nos últimos 3 meses. Para orientar a antibioticoterapia, o próximo exame mais adequado é:

A) Swab profundo do leito da úlcera

B) Cintilografia com leucócitos marcados

C) Hemoculturas

D) Biópsia óssea com cultura

---

4 Mulher de 58 anos, hipertensa, fez ultrassonografia por dor lombar mecânica, que mostrou formação cística de 5,6 cm no polo superior do rim direito. Sem hematúria, perda de peso ou história familiar de doença renal. Creatinina 0,8 mg/dL, EAS normal. A tomografia de rins sem e com contraste, com protocolo renal, mostrou cisto de conteúdo homogêneo, com densidade de 8 UH sem contraste e de 11 UH na fase nefrográfica, parede lisa e fina, um único septo fino de 1 mm, sem realce mensurável, e fina calcificação na parede, sem componente sólido ou nódulo. O rim esquerdo tem dois cistos simples de 1 cm. Em relação ao cisto do rim direito, a conduta mais adequada é:

A) Tomografia com contraste em 6 meses

B) Nefrectomia parcial

C) Nenhum seguimento por imagem

D) Ultrassonografia renal anual

---

5 Homem de 71 anos recebeu há 18 meses o diagnóstico de polimiosite por fraqueza progressiva e CK de 820 U/L. Usou prednisona em dose plena por 3 meses, hoje 10 mg/dia, e usa metotrexato 20 mg/semana, sem melhora: a fraqueza continua piorando lentamente. Refere quedas porque o joelho falseia, dificuldade para abotoar a camisa e segurar a xícara, e engasgos ocasionais. Exame: fraqueza assimétrica, mais intensa no quadríceps (grau 3 à direita, 4 à esquerda) e nos flexores profundos dos dedos, com deltoides grau 4+ e atrofia da face volar dos antebraços. CK 640 U/L. Sem lesões de pele, sem artrite, TC de tórax normal. Eletroneuromiografia com padrão miopático e potenciais de fibrilação. O diagnóstico mais provável é:

A) Miopatia induzida por corticoide

B) Polimiosite refratária

C) Miopatia necrotizante imunomediada

D) Miosite por corpos de inclusão

---

6 Mulher de 46 anos, G3P3, em indução de leucemia mieloide aguda, recebeu nos últimos 2 dias duas transfusões de plaquetas por aférese, ABO-idênticas e com menos de 48 horas de coleta. Primeira transfusão: plaquetas 5.000/mm³ antes e 7.000/mm³ 1 hora depois. Segunda: 6.000/mm³ antes e 8.000/mm³ 1 hora depois. Está afebril há 4 dias, sem sangramento ativo e sem esplenomegalia. TP, TTPa e fibrinogênio normais. Em uso de aciclovir e fluconazol profiláticos. O mecanismo mais provável da falta de resposta e a conduta para as próximas transfusões são, respectivamente:

A) Consumo não imune / dobrar a dose de plaquetas

B) Aloimunização anti-HLA / plaquetas HLA-compatíveis

C) Aloimunização anti-HLA / dobrar a dose de plaquetas

D) Consumo não imune / plaquetas HLA-compatíveis

---

7 Mulher de 31 anos, no 35º dia após parto vaginal sem intercorrências (perda sanguínea estimada de 300 mL, sem transfusão e sem hipotensão), amamenta exclusivamente com boa produção de leite. Tem cefaleia frontal progressiva há 3 semanas, náuseas, astenia e tontura ao levantar; refere cefaleia leve já no último mês da gestação. PA 92 × 60 mmHg em pé, sem alterações neurológicas, campos visuais normais à confrontação. Exames: sódio 128 mEq/L, potássio 4,1 mEq/L, glicemia 64 mg/dL, cortisol às 8 horas 1,8 mcg/dL, ACTH 6 pg/mL (VR 10 a 60), TSH 1,1 mUI/L, T4 livre 0,98 ng/dL (VR 0,9 a 1,8), prolactina 78 ng/mL. Ressonância de sela: hipófise aumentada de forma simétrica, com realce homogêneo e intenso pelo contraste, haste espessada, sem sinais de sangramento, quiasma livre. O diagnóstico mais provável é:

A) Hiperplasia hipofisária da gestação

B) Síndrome de Sheehan

C) Macroadenoma não funcionante

D) Hipofisite linfocítica

---

8 Mulher de 61 anos terminou há 7 semanas radioterapia adjuvante em mama e fossa supraclavicular direitas, após quadrantectomia por carcinoma ductal. Há 10 dias tem tosse seca, dispneia aos médios esforços e febre baixa (37,8 °C). Recebeu amoxicilina-clavulanato por 7 dias, sem melhora. SpO2 93%, estertores finos no ápice direito. Leucócitos 9.200/mm³, PCR 38 mg/L, procalcitonina 0,08 ng/mL. TC: vidro fosco com consolidação no lobo superior direito, com limite lateral retilíneo que não respeita fissuras nem segmentos; pulmão esquerdo normal. Não há derrame nem linfonodomegalia nova. O diagnóstico mais provável é:

A) Pneumonia bacteriana não responsiva

B) Linfangite carcinomatosa

C) Tromboembolismo pulmonar

D) Pneumonite actínica

---

9 Homem de 43 anos, natural do norte de Minas Gerais, previamente hígido, não fuma, sem diabetes, LDL de 98 mg/dL, tem síncope sem pródromos. ECG: bloqueio atrioventricular total com escape de QRS largo a 38 bpm; recebe marca-passo provisório. Relata tosse seca há 1 ano, que não investigou. Sorologias para doença de Chagas por dois métodos negativas. Não usa fármacos que deprimam a condução; TSH, potássio e troponina normais. Ecocardiograma: afilamento da porção basal do septo interventricular com hipocinesia, fração de ejeção de 48%, sem valvopatia. Cálcio sérico 10,9 mg/dL (VR 8,5 a 10,2). Antes de decidir o dispositivo definitivo, o exame mais indicado é:

A) Ressonância cardíaca com realce tardio

B) Biópsia endomiocárdica do ventrículo direito

C) Estudo eletrofisiológico invasivo

D) Cineangiocoronariografia

---

10 Mulher de 72 anos foi submetida a colectomia direita por adenocarcinoma de cólon ascendente, estádio II. Não tem história familiar de câncer de cólon, endométrio, ovário, estômago ou vias urinárias, e os pais morreram após os 80 anos por causas cardiovasculares. Como rotina, a peça foi submetida a imuno-histoquímica das proteínas de reparo de pareamento, que mostrou perda de expressão de MLH1 e PMS2, com MSH2 e MSH6 preservadas. Os dois filhos, de 44 e 46 anos, perguntam se precisam de colonoscopia precoce. O próximo exame mais adequado é:

A) Pesquisa de BRAF V600E no tumor

B) Sequenciamento germinativo de MLH1

C) Colonoscopia imediata dos dois filhos

D) Pesquisa de mutação germinativa de APC

---

11 Mulher de 61 anos tem esclerose sistêmica cutânea limitada há 9 anos, com anticorpo anticentrômero positivo, e colangite biliar primária diagnosticada há 4 anos, em uso de ácido ursodesoxicólico. Procura atendimento por cansaço e duas evacuações enegrecidas no último mês. Nega uso de anti-inflamatórios ou anticoagulantes. Exames: Hb 7,9 g/dL, VCM 71 fL, ferritina 6 ng/mL, plaquetas 248.000/mm³, albumina 4,0 g/dL, INR 1,0, bilirrubina total 0,8 mg/dL. Elastografia hepática de 6,1 kPa. Endoscopia digestiva alta: ausência de varizes; no antro, faixas eritematosas lineares que convergem radialmente para o piloro; fundo e corpo gástricos sem alterações. A causa mais provável do sangramento é:

A) Gastropatia da hipertensão portal

B) Angiodisplasias do intestino delgado

C) Ectasia vascular antral gástrica

D) Esofagite péptica erosiva

---

12 Homem de 24 anos é internado com doença meningocócica (meningite com petéquias; Neisseria meningitidis sorogrupo C na cultura do líquor). Na véspera dos sintomas, passou a tarde em reunião com uma colega de trabalho, na mesma sala, sem contato com secreções, e à noite jantou e dormiu em casa com a companheira, com quem mora. A companheira, de 27 anos, está com 9 semanas de gestação; a colega, de 30 anos, usa anticoncepcional oral. Ambas estão assintomáticas. A conduta de quimioprofilaxia para a colega de trabalho e para a companheira é, respectivamente:

A) Não indicada / ceftriaxona 250 mg IM

B) Rifampicina por 2 dias / ceftriaxona 250 mg IM

C) Não indicada / rifampicina por 2 dias

D) Rifampicina por 2 dias / ciprofloxacino oral

---

13 Mulher de 67 anos, com epilepsia focal por sequela de AVC em uso de levetiracetam (a família refere que ela ficou sem a medicação nos últimos 4 dias), teve em casa uma crise tônico-clônica bilateral de 3 minutos. No pronto-socorro, 15 minutos depois, recebeu diazepam 10 mg IV por agitação. Uma hora e meia após a crise, permanece com Glasgow 9 (abertura ocular à dor, sons incompreensíveis, localiza a dor), sem movimentos tônico-clônicos; observam-se piscamentos rítmicos e breves abalos intermitentes no canto esquerdo da boca. Tax 37,4 °C, PA 150/88 mmHg, glicemia 118 mg/dL, sódio 137 mEq/L, cálcio e magnésio normais. TC de crânio: encefalomalácia antiga temporoparietal direita, sem lesão nova. O diagnóstico mais provável é:

A) Estado pós-ictal prolongado

B) Sedação residual pelo diazepam

C) Estado de mal não convulsivo

D) AVC isquêmico de tronco encefálico

---

14 Homem de 66 anos, com diabetes tipo 2 há 18 anos e retinopatia, tem potássio entre 5,8 e 6,1 mEq/L em quatro dosagens nos últimos 3 meses, sem hemólise na amostra e com plaquetas e leucócitos normais. Usa insulina NPH, metformina e anlodipino; não usa IECA, BRA, espironolactona, betabloqueador, anti-inflamatório nem trimetoprima. PA 132/80 mmHg, sem hipotensão postural, sem hiperpigmentação. Exames: TFGe de 48 mL/min/1,73 m², sódio 138 mEq/L, cloro 110 mEq/L, bicarbonato 18 mEq/L, glicose 142 mg/dL, cortisol às 8 h de 16 mcg/dL; pH urinário de 5,2. O diagnóstico mais provável é:

A) Insuficiência adrenal primária

B) Acidose tubular distal por defeito de voltagem

C) Retenção de potássio pela queda da filtração

D) Hipoaldosteronismo hiporreninêmico

---

15 Mulher de 58 anos, com adenocarcinoma seroso de ovário em quimioterapia com carboplatina e paclitaxel, teve trombose venosa profunda femoral diagnosticada há 2 meses, tratada desde então com enoxaparina em dose plena (1 mg/kg de 12 em 12 horas). No 8º dia do ciclo atual, o controle mostra plaquetas de 38.000/mm³ (180.000/mm³ no início do ciclo), sem sangramento, sem petéquias e sem nova dor ou edema do membro. O Doppler de hoje mostra trombo residual não oclusivo, sem extensão proximal. Hb 10,4 g/dL, TFGe 76 mL/min/1,73 m², TP e TTPa normais, sem metástase cerebral. A conduta mais adequada quanto à anticoagulação é:

A) Reduzir a enoxaparina para dose profilática

B) Manter a enoxaparina em dose plena

C) Suspender e colocar filtro de veia cava

D) Trocar por anticoagulante oral direto

---

16 Homem de 62 anos, com cirrose alcoólica (Child-Pugh B), abstinente há um ano, usa espironolactona 200 mg/dia e furosemida 80 mg/dia por ascite. Em consulta de rotina refere aumento discreto do volume abdominal e nega confusão, cefaleia, náuseas ou quedas. Exame: lúcido, sem flapping, PA 104 × 64 mmHg, FC 82 bpm, ascite moderada, edema de membros inferiores 1+/4+. Exames: sódio 123 mEq/L (há 2 meses, 131), potássio 4,6 mEq/L, creatinina 1,1 mg/dL (basal 1,0), glicemia 98 mg/dL, osmolalidade sérica 262 mOsm/kg, TSH normal. A conduta mais adequada é:

A) Albumina e aumento da furosemida

B) Salina hipertônica a 3% em bolus

C) Suspender diuréticos e restringir água

D) Tolvaptana 15 mg por via oral

---

17 Mulher de 27 anos procura atendimento por cansaço aos grandes esforços há 1 ano. Usa aparelho auditivo desde a infância por surdez neurossensorial bilateral e foi operada de catarata congênita no primeiro ano de vida; a mãe conta que teve 'manchas vermelhas e ínguas atrás da orelha' no segundo mês da gestação e que a filha nasceu com baixo peso. Exame: PA 128×52 mmHg, FC 84 bpm, pulsos amplos e de colapso rápido nos quatro membros, ictus no 6º espaço intercostal, desviado para fora e com impulsão aumentada; SpO2 de 98% nas mãos e nos pés. ECG: sobrecarga ventricular esquerda. Radiografia de tórax: aumento de átrio e ventrículo esquerdos, botão aórtico proeminente e trama vascular pulmonar aumentada. O achado auscultatório esperado é:

A) Sopro holossistólico em borda esternal esquerda baixa

B) Sopro contínuo em maquinária infraclavicular esquerdo

C) Desdobramento fixo de B2 e sopro pulmonar

D) Sopro diastólico aspirativo em borda esternal esquerda

---

18 Homem de 52 anos procura atendimento por fraqueza, poliúria, dores ósseas e perda de 6 kg em 3 meses. Tem nefrolitíase recorrente há 2 anos. Há 1 mês notou rouquidão. Exame: massa cervical endurecida de 3 cm, à esquerda, abaixo do polo inferior da tireoide, pouco móvel. Laringoscopia: paralisia da prega vocal esquerda. Exames: cálcio 15,1 mg/dL (VR 8,5 a 10,2), PTH 1.240 pg/mL (VR 15 a 65), fósforo 1,9 mg/dL, fosfatase alcalina 610 U/L, creatinina 1,5 mg/dL. Após hidratação venosa e zoledronato, o cálcio caiu para 12,3 mg/dL no terceiro dia. Cintilografia com sestamibi: captação intensa e única na massa. Controlada a hipercalcemia, a conduta mais adequada é:

A) Paratireoidectomia minimamente invasiva

B) Cinacalcete e reavaliação em 3 meses

C) Ressecção em bloco com hemitireoidectomia

D) Punção aspirativa por agulha fina da massa

---

19 Homem de 66 anos, com miocardiopatia isquêmica (fração de ejeção de 25%) e DPOC (VEF1 38%), está internado há 5 dias por pneumonia lobar esquerda. No 2º dia, a toracocentese mostrou líquido turvo não purulento, pH 7,05, glicose 30 mg/dL, LDH 2.100 U/L e Gram negativo; recebeu dreno pleural de 24 F e ampicilina-sulbactam. O dreno eliminou 300 mL e parou. Hoje continua febril (38,6 °C), com PCR subindo; o dreno está pérvio e bem posicionado. Ultrassonografia: derrame residual volumoso com múltiplos septos. A cirurgia torácica considera o risco anestésico proibitivo. A interpretação e a conduta mais adequadas são, respectivamente:

A) Falha do antibiótico / trocar por meropeném

B) Derrame loculado / alteplase e dornase intrapleurais

C) Derrame loculado / decorticação por videotoracoscopia

D) Pulmão encarcerado / retirar o dreno

---

20 Mulher de 58 anos, com leucemia mieloide aguda em quimioterapia de consolidação, tem bacteremia por Enterococcus faecium resistente a ampicilina e a vancomicina (gene vanA), sensível a linezolida e com CIM de daptomicina de 2 mg/L. O cateter de longa permanência foi removido ontem; está estável e afebril desde então, e o ecocardiograma transesofágico não mostra vegetações. Plaquetas 38.000/mm³, com aplasia pós-quimioterapia esperada por mais 2 semanas; neutrófilos 900/mm³; creatinina 0,8 mg/dL; CK 60 U/L. Não usa estatina. O antimicrobiano mais adequado é:

A) Teicoplanina

B) Tigeciclina

C) Daptomicina em dose alta

D) Linezolida

---

21 Homem de 46 anos, trabalhador rural no interior de São Paulo, teve três episódios em 8 meses de urticária generalizada, angioedema labial e hipotensão, todos de madrugada, entre 3 e 5 horas depois do jantar, o último com necessidade de adrenalina intramuscular. Os jantares incluíam carne de porco ou de boi; o almoço, em geral frango ou peixe, nunca provocou sintomas. Refere picadas frequentes de carrapato no último ano. Usa ibuprofeno ocasionalmente, nunca nos dias das crises. Em outro serviço, foi rotulado com anafilaxia idiopática, e a triptase basal foi de 4,2 ng/mL (VR até 11,4). IgE total 310 UI/mL. A causa mais provável das reações é:

A) Alergia ao alfa-gal da carne de mamífero

B) Anafilaxia idiopática recorrente

C) Mastocitose sistêmica indolente

D) Hipersensibilidade ao ibuprofeno

---

22 No tratamento da leucemia linfoblástica aguda do adulto, independentemente do grupo de risco e diferentemente do tratamento padrão da leucemia mieloide aguda, faz parte obrigatória do protocolo:

A) Ácido all-trans retinoico

B) Agente hipometilante

C) Profilaxia do sistema nervoso central

D) Transplante autólogo de consolidação

---

23 Homem de 76 anos foi diagnosticado com doença de Parkinson há 1 ano por 'marcha arrastada e lentidão' e usa levodopa/benserazida até 600 mg/dia, sem melhora. A esposa conta que a marcha piorou progressivamente em 2 anos, com passos curtos, 'pés colados ao chão' e quedas, e que ele ficou mais lento para pensar e apático. Nega tremor e alucinações. Exame: sem tremor de repouso, sem rigidez apendicular, membros superiores com movimentos rápidos normais e balanço dos braços preservado; base alargada, dificuldade para iniciar a marcha e para girar; MoCA 21/30. RM de encéfalo: ventriculomegalia (índice de Evans 0,36) com sulcos altos da convexidade apertados e fissuras sylvianas alargadas; sem lesão obstrutiva. O exame mais adequado a seguir é:

A) Cintilografia com transportador de dopamina (TRODAT)

B) Punção lombar de alívio com teste da marcha

C) Cisternografia com radioisótopo

D) PET cerebral com FDG

---

24 Homem de 76 anos, com hiperplasia prostática, chega com retenção urinária há 3 dias. Creatinina 5,8 mg/dL, ureia 210 mg/dL, potássio 5,6 mEq/L, sódio 138 mEq/L. A sondagem vesical drena 2,1 L. Nas 12 horas seguintes a diurese se mantém entre 450 e 650 mL/h; ele está lúcido, mas sonolento à tarde, com PA de 132/80 mmHg deitado e 98/60 mmHg sentado, FC 108 bpm, mucosas secas. O sódio subiu para 149 mEq/L e a creatinina caiu para 3,9 mg/dL. Aceita mal a dieta e a água oferecidas. A conduta mais adequada para a reposição é:

A) Repor parte da diurese com salina a 0,45%

B) Repor 1:1 a diurese com SF 0,9%

C) Clampear a sonda por períodos alternados

D) Apenas liberar a ingestão oral

---

25 Homem de 29 anos foi submetido a orquiectomia radical por massa testicular; a histologia da peça descreve seminoma puro. No pós-operatório, a alfafetoproteína sérica é de 380 ng/mL (referência até 10) e a beta-hCG, de 45 mUI/mL. Para fins de estadiamento e tratamento, o tumor deve ser considerado:

A) Tumor espermatocítico

B) Não seminomatoso

C) Seminoma puro

D) Tumor de Leydig

---

26 Mulher de 66 anos, com diabetes tipo 2 em uso de metformina (HbA1c 7,0% há 1 mês), está internada há 2 dias por exacerbação de DPOC e recebe prednisona 40 mg às 8 horas, uma vez ao dia. Alimenta-se bem, pesa 70 kg e tem função renal normal. Recebe apenas insulina regular por escala, em média 16 unidades por dia. Glicemias capilares dos dois dias: jejum entre 112 e 124 mg/dL, antes do almoço 205 a 214 mg/dL, antes do jantar 318 a 342 mg/dL, às 22 horas 280 a 292 mg/dL e às 3 horas 138 a 146 mg/dL. Para o controle glicêmico, a conduta mais adequada é:

A) Glargina às 22 horas

B) Infusão venosa contínua de insulina

C) Ampliar a escala de insulina regular

D) NPH pela manhã, com a prednisona

---

27 Homem de 47 anos tem há 4 meses crises de dor, calor e vermelhidão nos dois pavilhões auriculares, poupando os lóbulos, que regridem em 1 a 2 semanas e deixaram as orelhas amolecidas. Há 2 meses notou afundamento do dorso nasal, sem obstrução, crostas ou epistaxe. Há 3 semanas tem rouquidão, tosse seca e dispneia aos esforços moderados, com chiado que não melhora com salbutamol. Teve episclerite à direita há 1 mês. Exame: SpO2 95%, estridor discreto à inspiração forçada, pavilhões auriculares flácidos, nariz em sela. VHS 68 mm/h, EAS normal, creatinina 0,8 mg/dL; ANCA por imunofluorescência e por ELISA negativos. O exame mais adequado neste momento é:

A) Ecocardiograma transtorácico

B) TC de tórax em inspiração e expiração

C) Biópsia da cartilagem auricular

D) Biópsia de mucosa nasal

---

28 Homem de 46 anos, com valva aórtica bicúspide conhecida e sem acompanhamento, está internado há 6 dias por endocardite por Staphylococcus aureus sensível à oxacilina, em uso de oxacilina, com hemoculturas negativas desde o 3º dia. Há 10 horas tem dispneia súbita e ortopneia. Exame: PA 96×62 mmHg, FC 124 bpm, FR 30 irpm, SpO2 89% com cateter de O2, extremidades frias, crepitações até os ápices, B1 hipofonética e sopro diastólico suave e curto na borda esternal esquerda; pulsos finos, sem sinais periféricos de pulso amplo. Ecocardiograma: perfuração de folheto aórtico com regurgitação grave, fechamento precoce da valva mitral, ventrículo esquerdo de diâmetro normal e fração de ejeção de 60%, sem abscesso. Lactato 3,8 mmol/L. A conduta mais adequada é:

A) Betabloqueador para reduzir a frequência

B) Completar o antibiótico antes de operar

C) Balão intra-aórtico como ponte

D) Troca valvar aórtica de emergência

---

29 Mulher de 39 anos, de Curitiba, sentiu ardência leve na coxa ao vestir uma calça guardada no armário, há 30 horas, sem ver o animal. Nas primeiras horas a dor foi pequena; depois a área ficou dolorosa, e hoje há placa de 6 cm com centro violáceo, áreas pálidas entremeadas e halo eritematoso, com bolha central. Há 12 horas tem febre, mal-estar e urina cor de refrigerante de cola. Exame: T 38,1 °C, PA 118 × 72 mmHg, mucosas hipocoradas e ictéricas, sem ptose ou alteração neurológica. Exames: Hb 8,4 g/dL (13,2 g/dL há 2 dias), reticulócitos 6%, LDH 1.450 U/L, bilirrubina indireta 3,8 mg/dL, Coombs direto negativo, CK 140 U/L, plaquetas 168.000/mm³, tempo de coagulação normal, creatinina 1,3 mg/dL. O diagnóstico mais provável é:

A) Fasciíte necrosante

B) Acidente crotálico

C) Acidente por Phoneutria

D) Loxoscelismo cutâneo-hemolítico

---

30 Mulher de 56 anos está no 12º dia de pós-operatório de clipagem de aneurisma cerebral roto, já na enfermaria, quando apresenta dispneia súbita e síncope. PA 72 × 40 mmHg após 1.000 mL de cristaloide, FC 128 bpm, SpO2 84% com máscara de reservatório, extremidades frias, lactato 5,1 mmol/L. Ecocardiograma à beira do leito: ventrículo direito muito dilatado e hipocinético, com trombo móvel no átrio direito. Angiotomografia: trombos nas duas artérias pulmonares principais. Noradrenalina já iniciada. O hospital tem cirurgia cardíaca e hemodinâmica disponíveis 24 horas. Além do suporte, a estratégia de reperfusão mais adequada é:

A) Alteplase 100 mg em 2 horas

B) Alteplase em meia dose (50 mg)

C) Embolectomia cirúrgica ou percutânea

D) Filtro de veia cava e heparina plena

---

31 Mulher de 41 anos tem há 2 meses dor lombar e na bacia, perda de 6 kg e dispneia aos esforços. Sem febre, sem alterações neurológicas. Hb 7,4 g/dL, reticulócitos 8%, leucócitos 11.000/mm³ com 4% de mielócitos e 6 eritroblastos por 100 leucócitos, plaquetas 38.000/mm³, esquizócitos 6% no esfregaço. LDH 1.450 U/L, bilirrubina indireta 2,6 mg/dL, haptoglobina indetectável, Coombs direto negativo. Creatinina 0,9 mg/dL, INR 1,2, fibrinogênio 210 mg/dL, fosfatase alcalina 610 U/L (VR até 120). A atividade da ADAMTS13 foi de 52%. O diagnóstico mais provável é:

A) Púrpura trombocitopênica trombótica adquirida

B) Coagulação intravascular disseminada aguda

C) Síndrome hemolítico-urêmica atípica

D) Microangiopatia associada a carcinoma disseminado

---

32 Homem de 61 anos, com doença do refluxo há 20 anos e esôfago de Barrett conhecido, faz endoscopia de vigilância com cromoscopia virtual em uso de IBP em dose plena. Há Barrett de 5 cm (Praga C4M5) com uma lesão levemente elevada (Paris 0-IIa), de 9 mm, às 3 horas, sem depressão ou ulceração, e mucosa plana no restante. A biópsia da lesão mostra displasia de alto grau, confirmada por segundo patologista experiente em trato digestivo; biópsias aleatórias em quatro quadrantes do restante do segmento mostram metaplasia intestinal sem displasia. TC de tórax e abdome sem linfonodomegalias. Bom estado geral, sem comorbidades relevantes. A primeira intervenção terapêutica mais adequada é:

A) Nova endoscopia com biópsias em 3 meses

B) Ressecção endoscópica da lesão visível

C) Ablação por radiofrequência do segmento

D) Esofagectomia com linfadenectomia

---

33 Mulher de 26 anos, com epilepsia mioclônica juvenil diagnosticada aos 15 anos (abalos matinais e duas crises tônico-clônicas generalizadas na adolescência), está sem crises há 4 anos com valproato de sódio 1.000 mg/dia. Casou-se e planeja engravidar daqui a 6 meses; usa preservativo. Não tem ausências nem mioclonias atuais. Exame normal; EEG recente com descargas esparsas de poliponta-onda generalizadas. A droga anticrise mais adequada e o momento da troca são, respectivamente:

A) Levetiracetam / antes da concepção

B) Levetiracetam / ao confirmar a gestação

C) Carbamazepina / antes da concepção

D) Carbamazepina / ao confirmar a gestação

---

34 Homem de 23 anos, que trabalha colando solados numa fábrica de calçados em galpão fechado, é trazido por fraqueza progressiva nas pernas há 2 dias. Nega vômitos, diarreia e uso de diuréticos ou laxantes. Força grau 3 proximal nos membros inferiores, reflexos hipoativos, PA 118/70 mmHg. Exames: sódio 137 mEq/L, potássio 2,2 mEq/L, cloro 115 mEq/L, bicarbonato 12 mEq/L, pH 7,27, pCO2 27 mmHg, glicose 92 mg/dL, creatinina 1,0 mg/dL. Urina: pH 6,0, sódio 40 mEq/L, potássio 35 mEq/L e cloro 30 mEq/L (ânion gap urinário de +45); gap osmolar urinário de 210 mOsm/kg. A causa mais provável da acidose é:

A) Acidose tubular distal (tipo 1)

B) Exposição ao tolueno

C) Acidose tubular proximal (tipo 2)

D) Perda intestinal oculta de bicarbonato

---

35 Homem de 34 anos, trabalhador rural, foi picado por serpente no pé esquerdo há 10 dias, com edema até o joelho e sangue incoagulável, e recebeu soro antibotrópico (12 ampolas), com alta no 4º dia. Há 2 dias tem febre de 38,3 °C, placas urticariformes pruriginosas disseminadas, dor e edema em punhos, joelhos e tornozelos, e linfonodomegalias inguinais e cervicais. O local da picada tem edema residual discreto, sem calor, flutuação ou necrose. Exames: leucócitos 9.800/mm³ sem desvio, plaquetas 210.000/mm³, tempo de coagulação normal, creatinina 1,0 mg/dL, EAS com proteína 1+ e sem hematúria, C3 e C4 baixos. O diagnóstico mais provável é:

A) Reação precoce ao antiveneno

B) Doença do soro

C) Abscesso da picada com bacteremia

D) Vasculite urticariforme hipocomplementêmica

---

36 Homem de 44 anos, com HIV diagnosticado há 1 mês (CD4 88 células/mm³), ainda sem TARV e sem profilaxias por não ter retornado, tem diarreia aquosa volumosa, sem sangue, há 6 semanas, com cólicas e perda de 7 kg. Exame: desidratação leve, afebril, abdome indolor. Hemograma: leucócitos 4.200/mm³, eosinófilos 1.100/mm³. Exame de fezes com coloração de Ziehl-Neelsen modificada: oocistos álcool-ácido resistentes, ovais, de 25 a 30 µm. Coprocultura e pesquisa de toxinas de C. difficile negativas. O agente mais provável é:

A) Cryptosporidium parvum

B) Cystoisospora belli

C) Cyclospora cayetanensis

D) Microsporídios

---

37 Mulher de 71 anos, com adenocarcinoma de ovário e carcinomatose peritoneal em progressão após a terceira linha de quimioterapia, em cuidados paliativos exclusivos, é internada por vômitos de aspecto fecaloide, distensão abdominal e cólicas há 4 dias, sem eliminação de flatos há três dias. Usa metoclopramida 10 mg de 8 em 8 horas desde o início dos vômitos e morfina oral. A TC mostra dilatação difusa de delgado com múltiplos pontos de transição por implantes peritoneais e ascite moderada; a cirurgia foi contraindicada pela equipe cirúrgica. PPS de 40%. A paciente quer evitar sonda nasogástrica prolongada. Quanto à metoclopramida e ao tratamento a associar, respectivamente:

A) Suspender metoclopramida / octreotida e dexametasona

B) Suspender metoclopramida / lactulose e enema

C) Manter metoclopramida / octreotida e dexametasona

D) Manter metoclopramida / lactulose e enema

---

38 Homem de 41 anos recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 2 há 14 meses, com glicemia de 290 mg/dL e HbA1c de 10,2%, sem cetoacidose. Iniciou metformina e, há 8 meses, gliclazida em dose máxima. Relata boa adesão e perdeu 7 kg sem fazer dieta; a HbA1c atual é de 9,6%. Tem hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto em uso de levotiroxina. Pais e irmãos sem diabetes. Exame: IMC 22,4 kg/m², PA 118 × 74 mmHg, sem acantose. Exames: triglicerídeos 88 mg/dL, HDL 62 mg/dL, creatinina normal, cetonúria negativa. Para orientar o tratamento, o próximo exame a ser solicitado é:

A) Cortisol após dexametasona 1 mg

B) Insulinemia de jejum e HOMA-IR

C) Teste genético para MODY

D) Anticorpo anti-GAD

---

39 Homem de 34 anos, padeiro há 3 anos, tem há 8 meses tosse, sibilância e aperto no peito que pioram ao longo da semana e melhoram nos fins de semana; nas férias de 20 dias ficou quase sem sintomas. Meses antes da tosse começou a ter coriza aquosa e espirros no trabalho. Nunca fumou. Espirometria feita há 2 semanas, numa segunda-feira pela manhã: VEF1/CVF 0,68, VEF1 78% do previsto, com aumento de 15% (310 mL) após broncodilatador. Continua trabalhando e ainda não usa medicações. O próximo exame mais adequado para estabelecer a relação com o trabalho é:

A) Broncoprovocação inespecífica com metacolina

B) Pico de fluxo seriado no trabalho e fora

C) IgE total e eosinófilos no sangue

D) TC de tórax de alta resolução em expiração

---

40 Homem de 67 anos teve proteína monoclonal IgG kappa de 3,4 g/dL achada na investigação de VHS elevada. Medula óssea com 34% de plasmócitos clonais. Hb 12,9 g/dL, cálcio 9,6 mg/dL, creatinina 1,0 mg/dL, relação de cadeias leves livres kappa/lambda de 22. Queixa-se de dor lombar mecânica há 2 meses. Radiografias do esqueleto (inventário ósseo) e cintilografia óssea com tecnécio não mostraram lesões. O próximo exame para completar a avaliação é:

A) Repetir cintilografia óssea em 6 meses

B) TC de corpo inteiro de baixa dose

C) Densitometria óssea de coluna e fêmur

D) Nenhum, iniciar observação trimestral

---

41 Homem de 36 anos, motorista de ônibus intermunicipal, faz ECG no exame periódico do trabalho. Nunca teve palpitações, síncope, pré-síncope ou dispneia. ECG: ritmo sinusal, PR de 100 ms, onda delta e QRS de 124 ms. Ecocardiograma normal. Teste ergométrico máximo: a pré-excitação persiste até o pico do esforço, com FC de 176 bpm, sem arritmias. Holter de 24 horas: pré-excitação contínua, sem arritmias. Não tem história familiar de morte súbita. O próximo passo mais adequado é:

A) Propafenona contínua

B) Holter de 7 dias

C) Estudo eletrofisiológico invasivo

D) Seguimento clínico, sem novos exames

---

42 Mulher de 22 anos, com diagnóstico de epilepsia desde os 16 anos, usa carbamazepina 400 mg de 12/12 horas e foi encaminhada por 'crises refratárias'. Os episódios, cerca de quatro por ano, são de perda súbita de consciência com queda e abalos generalizados por 15 a 20 segundos, com recuperação em 1 a 2 minutos e sem confusão prolongada; dois ocorreram ao ser acordada pelo despertador e um ao ouvir o telefone tocar durante o banho. Um primo morreu afogado aos 19 anos. EEG interictal normal em duas ocasiões; RM de encéfalo normal. Exame físico normal, PA 112/70 mmHg, FC 56 bpm. Potássio 4,1 mEq/L, magnésio 2,0 mg/dL. ECG: ritmo sinusal, QTc de 510 ms, ondas T bífidas de V2 a V4. O diagnóstico mais provável é:

A) Epilepsia generalizada agravada pela carbamazepina

B) Epilepsia focal refratária do lobo temporal

C) Crises não epilépticas psicogênicas

D) Síndrome do QT longo congênito

---

43 Mulher de 22 anos, com anorexia nervosa (IMC 12,8 kg/m²), foi internada por desnutrição grave e recebe dieta enteral plena de 2.200 kcal/dia desde a admissão; os eletrólitos da admissão eram normais. No terceiro dia está confusa, com fraqueza generalizada, dispneia e edema de membros inferiores. PA 96/60 mmHg, FC 118 bpm, SpO2 91% em ar ambiente, estertores em bases. Exames: fósforo 0,9 mg/dL, potássio 2,8 mEq/L, magnésio 1,2 mg/dL, glicose 168 mg/dL, CK 2.400 U/L. Ainda não recebeu tiamina. A conduta mais adequada é:

A) Manter a dieta e repor fosfato oral

B) Reduzir a dieta e repor fosfato intravenoso

C) Suspender a dieta e infundir glicose a 10%

D) Manter a dieta e iniciar furosemida

---

44 Homem de 56 anos, agricultor, tem artralgias migratórias há seis anos, em joelhos, punhos e tornozelos, com fator reumatoide e anti-CCP negativos, rotuladas como artrite soronegativa e tratadas com prednisona em doses baixas. IGRA negativo e radiografia de tórax normal antes de iniciar adalimumabe, há 5 meses. Desde então, diarreia com 5 a 6 evacuações volumosas e gordurosas ao dia, distensão, perda de 12 kg e febre baixa vespertina. Exame: Tax 37,8 °C, hiperpigmentação difusa da pele, linfonodos axilares e inguinais de 1,5 cm, móveis e indolores, sem lesões orais. Exames: Hb 10,2 g/dL, albumina 2,6 g/dL, PCR 6,8 mg/dL, antitransglutaminase IgA negativo com IgA total normal, sorologia anti-HIV não reagente, TC de abdome com linfonodos mesentéricos e retroperitoneais de baixa atenuação. O diagnóstico mais provável é:

A) Tuberculose intestinal

B) Linfoma intestinal

C) Doença de Whipple

D) Doença celíaca soronegativa

---

45 Estudante de 19 anos tem há 12 dias febre, faringite exsudativa, linfonodomegalia cervical posterior e esplenomegalia, com anticorpo heterófilo reagente. Há 3 dias notou cansaço aos esforços e urina escura. Exames: Hb 8,9 g/dL, VCM 104 fL, reticulócitos 8%, LDH 980 U/L, bilirrubina indireta 2,9 mg/dL; esfregaço com aglutinação de hemácias em lâmina à temperatura ambiente, que desaparece a 37 °C; Coombs direto positivo apenas para C3d. Radiografia de tórax normal. O autoanticorpo mais provável é:

A) IgM anti-i

B) IgM anti-I

C) IgG anti-Rh

D) IgG bifásica anti-P

---

46 Mulher de 62 anos tem há 2 anos crises de dor e edema em interfalângicas distais e proximais das mãos, com rigidez matinal de 20 minutos. Exame: nódulos de Heberden e de Bouchard, com sinovite em 2ª e 3ª interfalângicas proximais e 4ª interfalângica distal direitas; metacarpofalângicas, punhos e unhas normais; sem lesões de pele. FR e anti-CCP negativos, PCR 7 mg/L (VR < 5), ácido úrico 5,1 mg/dL. Radiografia: redução do espaço articular, osteófitos e erosões centrais subcondrais nas interfalângicas, sem proliferação óssea periarticular e sem osteopenia justa-articular. Usa paracetamol com alívio parcial. A conduta mais adequada é:

A) AINE tópico, órtese e exercícios

B) Prednisona 10 mg/dia contínua

C) Metotrexato 15 mg/semana

D) Hidroxicloroquina 400 mg/dia

---

47 Homem de 64 anos fez angioplastia coronária por infarto sem supradesnivelamento de ST há 19 dias, com heparina não fracionada no procedimento e enoxaparina por 3 dias. Foi readmitido ontem por celulite da perna esquerda, com cefazolina e enoxaparina 40 mg/dia profilática. Plaquetas: 236.000/mm³ ontem, à admissão, e 88.000/mm³ hoje, 24 horas depois, confirmadas em amostra com citrato e sem agregados. Afebril há 12 horas, PA 132/80 mmHg, sem sangramento, sem sinais de trombose. Usa AAS e clopidogrel. TFGe 78 mL/min/1,73 m². A conduta mais adequada é:

A) Suspender heparina e iniciar fondaparinux

B) Manter enoxaparina e repetir plaquetas em 48 h

C) Trocar enoxaparina por heparina não fracionada

D) Suspender heparina e transfundir plaquetas

---

48 Homem de 68 anos está no 9º dia de UTI por choque séptico de foco pulmonar, em ventilação mecânica, com noradrenalina em redução, dieta enteral plena e hidrocortisona 200 mg/dia. Não tem doença tireoidiana prévia e não recebeu amiodarona nem contraste iodado. Nega cefaleia ou alterações visuais antes da internação. Exames: TSH 0,28 mUI/L (VR 0,4 a 4,0), T4 livre 0,82 ng/dL (VR 0,9 a 1,8), T3 total 38 ng/dL (VR 80 a 180), T3 reverso elevado, sódio 137 mEq/L, glicemia 152 mg/dL. O diagnóstico e a conduta mais adequados são, respectivamente:

A) Eutireoidiano doente / repetir após a recuperação

B) Eutireoidiano doente / liotironina venosa

C) Hipotireoidismo central / levotiroxina em dose baixa

D) Hipotireoidismo central / repetir após a recuperação

---

49 Homem de 74 anos, diabético há 12 anos, tem há 6 semanas prurido intenso e, há 3 semanas, bolhas tensas de conteúdo claro sobre pele eritematosa em coxas, abdome e face flexora dos antebraços. A mucosa oral está poupada e o sinal de Nikolsky é negativo. Há 4 meses o endocrinologista trocou a glibenclamida por um comprimido único que associa metformina a outro antidiabético oral, e ele não sabe o nome. Usa há anos losartana, anlodipino e atorvastatina. Biópsia: clivagem subepidérmica com eosinófilos; imunofluorescência direta com IgG e C3 lineares na zona da membrana basal. Glicemia bem controlada, sem perda de peso. A classe de medicamento com maior probabilidade de ter desencadeado o quadro é:

A) Inibidores da DPP-4

B) Biguanidas

C) Inibidores do SGLT2

D) Bloqueadores do receptor AT1

---

50 Mulher de 52 anos, com carcinoma de mama HER2 positivo, operada, recebeu 4 ciclos de doxorrubicina e ciclofosfamida e está no 5º mês de trastuzumabe adjuvante. Assintomática, caminha 40 minutos por dia. PA 126×78 mmHg, FC 78 bpm, sem congestão. Ecocardiograma de monitorização: fração de ejeção de 55% (basal de 63%) e queda relativa de 17% do strain longitudinal global em relação ao basal. Troponina I ultrassensível de 18 ng/L (basal 6; referência até 16) e NT-proBNP de 210 pg/mL. A conduta mais adequada é:

A) Interromper até normalizar a fração de ejeção

B) Suspender e iniciar dexrazoxano

C) Manter trastuzumabe com cardioproteção

D) Suspender o trastuzumabe definitivamente

FOLHA DE RESPOSTAS

Simulado 8

Nome: _____ Data: ___/___/_____ Início: ___h___ Fim: ___h___

1	A	B	C	D	2	A	B	C	D	3	A	B	C	D	4	A	B	C	D
5	A	B	C	D	6	A	B	C	D	7	A	B	C	D	8	A	B	C	D
9	A	B	C	D	10	A	B	C	D	11	A	B	C	D	12	A	B	C	D
13	A	B	C	D	14	A	B	C	D	15	A	B	C	D	16	A	B	C	D
17	A	B	C	D	18	A	B	C	D	19	A	B	C	D	20	A	B	C	D
21	A	B	C	D	22	A	B	C	D	23	A	B	C	D	24	A	B	C	D
25	A	B	C	D	26	A	B	C	D	27	A	B	C	D	28	A	B	C	D
29	A	B	C	D	30	A	B	C	D	31	A	B	C	D	32	A	B	C	D
33	A	B	C	D	34	A	B	C	D	35	A	B	C	D	36	A	B	C	D
37	A	B	C	D	38	A	B	C	D	39	A	B	C	D	40	A	B	C	D
41	A	B	C	D	42	A	B	C	D	43	A	B	C	D	44	A	B	C	D
45	A	B	C	D	46	A	B	C	D	47	A	B	C	D	48	A	B	C	D
49	A	B	C	D	50	A	B	C	D										